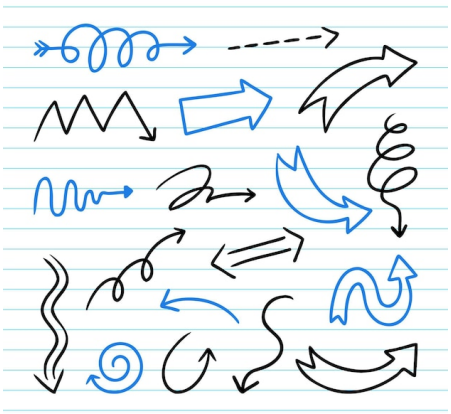


TEMA 49



ESQUEMA DEL TEMA

ADICCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS.

LEY 5/2.002 DE 27 DE JUNIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID.

LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. SERVICIOS PRESTADOS.

COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA.

ADICCIONES. CONCEPTOS BÁSICOS.

1.- LAS SUSTANCIAS.

Sustancias depresoras.	Alcohol, barbitúricos, benzodiacepinas, heroína, metadona …
Sustancias estimulantes.	Anfetaminas, cocaína, crack, drogas de síntesis, tabaco, cafeína …
Sustancias perturbadoras.	Derivados del cannabis, drogas de síntesis, hongos, ketamina, LSD …

2.- ETIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES → ETIOLOGÍA MULTIFACTORIAL.

. Biologicista.

. Psicologicista.

. Sociologista.

. Ético-Jurídica.

. Integradora → Interdisciplinar e intersectorial → MODELO BIO-PSICO-SOCIAL: factores propios del individuo, relacionados con las influencias del medio social y de las características de la sustancia.

3.- FORMAS DE CONSUMO.

Las formas de consumo están relacionadas con muchos factores: cantidad de sustancia, pureza de la dosis, frecuencia del consumo, vía del consumo, duración del consumo …

Consumos experimentales.	Contacto inicial con sustancias. Suelen aparecer en la adolescencia. Normalmente los individuos desconocen los efectos. Se suelen realizar en grupo.
Consumos ocasionales.	Uso intermitente de la sustancia, períodos de abstinencia. Se sigue consumiendo en grupo. La sustancia empieza a tener efectos en el organismo.
Consumos habituales.	Utilización frecuente de la droga. Puede llevar a otras formas de consumo. Se amplían las situaciones de consumo de las drogas. Se consumen de manera individual y grupal.
Consumos compulsivos o drogodependencias.	El individuo necesita la sustancia → utilización en mayor cantidad y períodos de tiempo, toma de conciencia sobre la dificultad de control, aumento del tiempo para la obtención de la sustancia, reducción de otras actividades, tolerancia, síndrome de abstinencia …

LEY 5/2.002, DE 27 DE JUNIO, SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1 Título Preliminar, 6 Títulos, 62 artículos, 3 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

Título Preliminar.	Disposiciones generales.
Título I. Reducción de la demanda a través de medidas preventivas.	. Capítulo I. Prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos . Capítulo II. Prevención escolar y comunitaria de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.
Título II. Asistencia e integración.	. Capítulo I. Asistencia a drogodependientes. . Capítulo II. De los derechos y deberes de los pacientes. . Capítulo III. Del sistema de asistencia al drogodependiente. . Capítulo IV. De la integración del drogodependiente. . Capítulo V. De los centros de asistencia e integración en el ámbito de las drogodependencias.
Título III. Del control a la oferta.	. Capítulo I. De las limitaciones a la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y tabaco. . Capítulo II. De las limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. . Capítulo III. De las limitaciones a la venta y consumo de tabaco. . Capítulo IV. Estupefacientes y psicótropos. . Capítulo V. Otras medidas.
Título IV. De la organización y competencias de las AA.PP.	
Título V. De la financiación.	
Título VI. Del régimen de infracciones y sanciones.	. Capítulo I. De la inspección y medidas cautelares. . Capítulo II. De las infracciones y sanciones.

TÍTULO PRELIMINAR.

Objeto.	Regular las actuaciones e iniciativas de la CM en el campo de las drogodependencias y otros trastornos adictivos (DTA) → prevención, asistencia, integración social, formación y evaluación y protección de terceras personas, ajenas al consumo.
Ámbito de aplicación.	Actuaciones individuales y colectivas, públicas y privadas en DTA en la CM.

Destinatarios.	. Todos los españoles residentes o transeúntes en la CM y extranjeros inscritos en el Padrón Municipal de la CM en que residan habitualmente. . Extranjeros en situaciones de urgencia, extranjeras embarazadas (embarazo, parto y posparto) y extranjeros menores de edad. - Especial atención a la infancia y la adolescencia.

PLANTEAMIENTOS BÁSICOS

Realidad del consumo.	1.- Fenómeno complejo y cambiante → graves trastornos familiares, sociales y económicos. 2.- Falsa creencia de la inocuidad de sustancias + dificultad legal para perseguir nuevas sustancias. 3.- Carácter urbano de las DTA. 4.- Enfoque global → perspectiva biopsicosocial → coordinación entre los recursos asistenciales especializados y la red pública sociosanitaria. **Definición de droga:** "toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social".
Conceptos.	. Trastorno adictivo. . Drogodependencia. . Drogodependiente. . Prevención. . Tratamiento. . Desintoxicación. . Deshabituación. . Rehabilitación. . Integración. . Reducción de daños y riesgos. . Evaluación. . Centros socio-sanitarios.
Principios generales.	. Principios rectores: 1.- Responsabilidad pública y coordinación institucional. 2.- Descentralización, responsabilidad, equidad y autonomía en la gestión de programas y servicios. 3.- Participación activa de la comunidad y los afectados. . Intervención sobre las condiciones ambientales y socioculturales. . Promoción activa de hábitos de vida saludables y una cultura de salud. . Consideración de la DTA como enfermedad común. . Consideración integral e interdisciplinar del proceso de prevención / asistencia / integración social.

	. Selección de actuaciones en el marco de la ordenación sanitaria y la acción social. . Aplicación del principio de equidad en la salud → acceso igualitario a los servicios.

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE MEDIDAS PREVENTIVAS.

Intervención en las condiciones sociales y factores de riesgo de consumo de drogas.

1.- Información adecuada, oportuna, veraz y científicamente contrastada.

2.- Educación para la salud → Cultura de la salud / rechazo a las drogas.

3.- Formación a los profesionales (prevención).

4.- Promoción de factores de protección.

5.- Modificación de las percepciones, actitudes y comportamientos de la población.

6.- Adopción de medidas para evitar perjuicios para la salud.

7.- Promoción de acciones preventivas para la población infantil, adolescente y de especial riesgo.

8.- Programas de prevención comunitaria, educativa, familiar y laboral.

9.- Coordinación e impulso de actividades de prevención en AA.PP., Asociaciones, colectivos sociales …

10.- Acuerdos de colaboración con organizaciones sindicales y empresariales.

11.- Convenios con Organismos e Instituciones Públicas, Universidades …

12.- Limitación de la presencia, promoción y venta de drogas.

13.- Fomento de alternativas de ocio y tiempo libre → reducción de la atracción y de la demanda de drogas.

14.- Toma de conciencia sobre el carácter de drogas del alcohol y el tabaco.

15.- Sistemas de información → conocimiento permanente y evolución de los patrones de consumo.

16.- Fomento del movimiento asociativo juvenil → programas culturales, de ocio, deportivos …

Ámbitos prioritarios de prevención en DTA.

. Ámbitos comunitario, escolar, familiar y laboral → actividades con participación activa de las organizaciones y asociaciones sociales.

- ➔ Las actuaciones de prevención de las drogodependencias se enmarcan en el ámbito general de promoción y educación para la salud.
- ➔ Los programas preventivos fomentan comportamientos alternativos a los consumos.
- ➔ Se dirigen preferentemente a la población infantil, adolescente y otras en especial riesgo.

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN.

ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES.

Finalidad de las acciones asistenciales:

1.- Asistencia a personas afectadas por DTA en condiciones de equidad con otras enfermedades → calidad y eficacia de los servicios y programas en la red sanitaria única.

2.- Programas de integración social como objetivo del proceso asistencial → estrategias de acceso y mantenimiento en el ámbito laboral.

3.- Respeto a los derechos de las personas drogodependientes como usuarios de los servicios.

4.- Adecuar los dispositivos de la red pública a las necesidades de las personas drogodependientes → acceso libre a los dispositivos.

5.- Mejorar los niveles de salud y calidad de vida.

6.- Reducir la problemática social y jurídico-penal.

7.- Cultura social favorecedora de la solidaridad y colaboración de la comunidad / rechazo al consumo.

8.- Cooperación con las ONGs y las asociaciones de auto-ayuda de afectados y familiares.

Criterios de actuación de los servicios sanitarios públicos de atención a drogodependientes:

1.- Oferta terapéutica accesible y diversificada, profesionalizada e interdisciplinar → tipologías de tratamiento de eficacia científica reconocida, incluyendo los de reducción de riesgos y daños:

- Prevención de enfermedades y asesoramiento y apoyo psicológico.

- Prescripción y dispensación de medicación sustitutiva.

- Educación sanitaria para evitar la transmisión de enfermedades.

2.- Asistencia en el ámbito comunitario → proximidad al domicilio y al entorno → dispositivos ambulatorios.

3.- Atención a través del sistema sanitario público y del sistema de SS.SS. de la CM / Incorporación, si es necesario, de recursos privados para completar y diversificar los programas.

4.- Objetivos principales de la atención sanitaria: desintoxicación, deshabituación, disminución de riesgos, reducción de daños y mejora de las condiciones generales de salud.

- Objetivo final del proceso asistencial: integración social.

5.- La integración social se apoya en las redes generales, en la familia y en el entorno afectivo.

6.- Evaluación permanente de la calidad de los procesos y resultados de los centros, servicios, modelos.

Actuaciones de la Administración de la CM (en colaboración con las entidades privadas):

1.- Atención en las redes generales de los sistemas sanitarios y de SS.SS. desde un enfoque multidisciplinar.

2.- Adecuación progresiva de la oferta en centros específicos.

3.- Inspección y control periódico de los centros, servicios y establecimientos, públicos o privados.

4.- Disminución de riesgos, reducción de daños y mejora de las condiciones sociales y sanitarias → educación sanitaria, asesoramiento y apoyo psicológico a personas portadoras de enfermedades transmisibles.

5.- Programas específicos para población de alta cronicidad y máximo riesgo → sustitutivos opiáceos.

6.- Programas de integración social y asesoramiento a familiares, formación ocupacional y profesional.

7.- Sensibilización de la sociedad en general → participación activa y solidaria de la comunidad.

8.- Programas específicos para mujeres drogodependientes con cargas familiares no compartidas y otros factores de riesgo.

9.- Equiparación del drogodependiente a otros enfermos y consideración de la drogodependencia como enfermedad.

Actuaciones en el ámbito judicial y penitenciario:

1.- Programas de educación sanitaria y atención → reducción de riesgos y daños y mejora de la salud.

2.- Asistencia al penado en el medio penitenciario.

3.- Ofrecer medidas alternativas al cumplimiento de la pena en recursos de la red pública.

4.- Acceso a recursos asistenciales normalizados en el medio comunitario cuando se haya cumplido la pena.

5.-Atención a los problemas de naturaleza jurídico-penales de la población drogodependiente.

Actuaciones en el ámbito laboral:

1.- Programas de prevención y asistencia de trabajadores con problemas de consumo, incluidos alcohol y tabaco y otros TA → participación de sindicatos, organizaciones empresariales y servicios de prevención.

2.- Reserva de puesto de trabajo durante el proceso de recuperación (en las empresas).

3.- Reserva del puesto de trabajo en los centros y servicios de la CM.

4.- Lograr que las drogodependencias no sean un instrumento de discriminación en el ámbito laboral.

SISTEMA DE ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE → red de atención púbica diversificada → centros y servicios generales y específicos, complementados con recursos privados acreditados.

- Los centros y servicios sociosanitarios están sujetos a medidas de inspección, control e información estadística, sociosanitaria.
- Se estructura en dos niveles de intervención: Primer nivel (atención básica → información, orientación, diagnóstico, detección precoz, reducción del daño) y Segundo nivel (unidades específicas).
- Competencias de la DG de Salud Pública en esta materia.

INTEGRACIÓN DE LOS DROGODEPENDIENTES.

Criterios generales de integración:

1.- Es asumida desde los organismos competentes en materia de drogodependencias y SS.SS. de la CM.

2.- La integración social es parte de un plan global de intervención sobre el individuo, entorno y comunidad → Es un proceso flexible con objetivos mínimos, intermedios y definitivos → autonomía personal, autoestima y asunción de responsabilidades.

3.- Igualdad en el acceso a recursos, actividades y prestaciones del sistema en las acciones normalizadas de los servicios públicos.

4.- Utilización conjunta y coordinada de los programas de la red de servicios sociosanitarios y de SS.SS.

5.- Promoción del movimiento asociativos, integración social y familiar y fomento del voluntariado.

6.- Evaluación de los recursos destinados a la integración.

La integración social se realizará mediante una intervención individual y comunitaria.

Programas destinados a la adquisición y desarrollo de estrategias y recursos personales y sociales:

- En el ámbito familiar → apoyo y asistencia del entorno familiar.
- En el ámbito laboral → acceso al empleo: información profesional, técnicas de búsqueda de empleo, planes de formación …
- En el ámbito de la juventud → grupos preventivos, integración de la juventud marginada … → capacitación profesional, empleo, vivienda …

CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DEL DROGODEPENDIENTE.

Centros públicos y privados que realizan actuaciones específicas en drogodependencias → Proporcionar programas terapéuticos dirigidos a eliminar la adicción, normalizar la conducta y conseguir la integración social.

Requisitos mínimos:

- Personal suficiente titulado / Instalaciones y equipamientos adecuados.
- Régimen de funcionamiento interno.

COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

Ayuntamientos	. Determinación de criterios de localización, distancia y requisitos de establecimientos de bebidas alcohólicas y tabaco. . Otorgamiento de la licencia de apertura y funcionamiento de los establecimientos de alcohol y tabaco. . Cumplimiento de las medidas de control (especialmente en las dependencias municipales). . Adopción de medidas cautelares.
Ayuntamientos > 20.000 hab.	. Aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre DTA. . Ejecución de programas de prevención de ámbito municipal. . Fomento de la participación social y apoyo a instituciones sin ánimo de lucro.

PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID, 2.022-2.026.

1.- MARCO NORMATIVO.

Unión Europea.	. Estrategia 2.021-2.025 → Proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y las personas, salvaguardar y promover la salud pública + Perspectiva de igualdad de género + Equidad sanitaria → reducción de la oferta, reducción de la demanda y abordaje de los daños.
España.	. Constitución Española: art 43 (derecho a la protección de la salud). . Estrategia sobre Adicciones, 2.017-2.024 → perspectiva de género, transparencia, evidencia científica, participación … . L.O. 4/2.015, protección de la seguridad ciudadana.
Comunidad de Madrid.	. Ley 5/2.002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. . Ley 12/2.001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la CM.
Ayuntamiento de Madrid.	. Creación de la Comisión Antidroga, 31 de julio de 1.987. . Estatutos del Organismo Autónomo Madrid-Salud, 2.004.

2.- PRINCIPIOS Y CRITERIOS ORIENTADORES DEL PLAN.

. Compromiso ético → humanidad, autonomía, justicia e inocuidad, respeto de los derechos humanos.

. Enfoque integral → adicciones como fenómeno complejo, multicausal y multifactorial / modelo bio-psico-social.

. Universalidad y equidad → igualdad de condiciones y sin discriminación / prestaciones de carácter público.

. Intersectorialidad → coordinación y cooperación entre las redes.

. Integración y normalización → Integración social y utilización de los recursos normalizados.

. Adaptabilidad e innovación → conocimiento de las necesidades emergentes y dar respuestas adaptadas.

. Calidad y evidencia científica → mejora continua, satisfacción de los usuarios, eficiencia, efectividad, evidencia científica.

. Perspectiva de género → adaptación a las características y necesidades diferenciadas de hombres y mujeres → condicionantes de género / tratamientos centrados en las mujeres / atención a mujeres que sufren VG.

. Perspectiva de diversidad identitaria → atención a personas con identidades diversas.

. Reducción del estigma → cambio de percepción del estigma mediante la información y sensibilización a la población y a los profesionales sociosanitarios.

MISIÓN.

Evitar o reducir los problemas de adicción, así como los daños y consecuencias que pueden afectar a la persona adicta, a su entorno familiar y social y a la comunidad.

3.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención frente a los riesgos relacionados con las adicciones.

• Sensibilizar, informar y formar a la población general y de forma específica a adolescentes y jóvenes sobre prevención de adicciones, así como incrementar la visibilidad y accesibilidad de los recursos del Instituto de Adicciones.

- Establecer y desarrollar espacios digitales y canales de información con la ciudadanía.
- Sensibilizar e informar a la plantilla del Ayuntamiento sobre prevención en adicciones.

• Promover acciones de prevención selectiva dirigidas a adolescentes y jóvenes, familiares y otras personas adultas de referencia para aumentar la percepción de riesgo y retrasar la edad de inicio en la experimentación con sustancias o con diversos objetos de adicción.

- Realizar prevención selectiva en el ámbito educativo.
- Incorporar la perspectiva de género en la prevención de adicciones.
- Realizar prevención en el ámbito comunitario.
- Realizar programas preventivos en proximidad específicos.
- Realizar prevención ambiental y programas de reducción de riesgos.

• Potenciar la detección precoz y captación proactiva de adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción.

- Identificar, contactar y motivar, en su entorno, a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o con alguna dimensión de la conducta adictiva.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Atención integral a adolescentes y jóvenes, tanto los que presentan una situación de riesgo como quienes cumplen criterios de adicción.

• Ofrecer a adolescentes y jóvenes atención integral, tanto los que presentan una situación de riesgo como quienes cumplen criterios de adicción a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).

- Adaptar el Plan Personalizado de Intervención al perfil de situación de adolescentes y jóvenes.
- Ofrecer a adolescentes y jóvenes con riesgo de adicción una intervención preventiva adaptada a sus necesidades.
- Ofrecer a adolescentes y jóvenes con criterios de adicción una intervención terapéutica acorde a sus necesidades.
- Favorecer la integración social de las personas adolescentes y jóvenes atendidas con criterios de normalización y adaptando a las necesidades sociales propias de cada persona.

• Ofrecer recursos específicos para la atención integral de adolescentes y jóvenes.

- Ofrecer a adolescentes y jóvenes con adicciones recursos de apoyo al tratamiento.

• Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes intervenciones preventivas y/o terapéuticas.

- Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes en riesgo de desarrollar una adicción intervenciones preventivas.
- Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes con una adicción intervenciones terapéuticas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Reducción de los riesgos y daños asociados a las adicciones.

• Garantizar la existencia de recursos y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas en situación de consumo activo.

- Potenciar la implantación y desarrollo de servicios de atención en proximidad de los distritos.
- Potenciar las salas de reducción del daño para personas con problemas con el alcohol en los centros de la red social de atención a PSH.
- Promover la formación de agentes de salud en los recursos y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas en situación de consumo activo.
- Potenciar la red de recursos de reducción del daño.
- Promover la sensibilización y formación en aspectos relacionados con la reducción del daño.

• Promover medidas de mediación comunitaria.

- Disminuir la conflictividad en las inmediaciones de los dispositivos de atención.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Tratamiento integral de las personas con adicciones.

• Ofrecer tratamiento integral a las personas con adicciones a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).

- Mejorar la accesibilidad a los CAD.
- Reducir el estigma asociado a los tratamientos de adicciones.
- Ofrecer a una intervención integral, basada en la evidencia y la calidad a las personas con adicciones en tratamiento en los CAD.
- Ofertar tratamientos farmacológicos para el trastorno por consumo de opioides, adaptados a la situación de cada persona.
- Ofrecer tratamiento integral de la patología dual.
- Impulsar la prevención, detección precoz e intervención frente a las diversas patologías infecciosas asociadas al consumo.
- Adaptar las intervenciones terapéuticas para personas mayores, crónicos y/o con deterioro cognitivo.
- Tratar a personas usuarias de chemsex.

• Facilitar la integración sociorrelacional y laboral de pacientes mediante actividades dirigidas al desarrollo de sus habilidades sociales, culturales, formativas y laborales.

- Favorecer la integración social de las personas atendidas con criterios de normalización y adaptado a las necesidades sociales propias de cada persona.
- Favorecer la integración laboral de las personas en tratamiento y adaptada a las necesidades sociolaborales de cada persona.
- Favorecer la integración social de las personas con problemas judiciales asociados a una problemática adictiva mediante una atención especializada, durante el proceso jurídico penal, tanto a las personas afectadas como a sus familiares.
- Facilitar la integración socio relacional de las personas en tratamiento atendiendo sus necesidades de ocio.

• Garantizar la existencia de una red de dispositivos hospitalarios y residenciales terapéuticos de apoyo al tratamiento integral.

- Potenciar recursos especializados en apoyo al tratamiento integral.
- Optimizar la utilización de los recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción.
- Mantener, supervisar y garantizar la calidad de los recursos existentes.

• Potenciar las actuaciones específicas de tratamiento integral para mujeres.

- Identificar y reducir las brechas que impiden o dificultan el acceso de las mujeres a la atención y el tratamiento en los CAD y romper el estigma de las mujeres con adicciones.
- Ofrecer a las mujeres con adicciones una intervención integral, de calidad y basada en la evidencia adaptada a sus necesidades.
- Fomentar programas específicos en todos los recursos de la red: reducción del daño, apoyo al tratamiento y reinserción.
- Aumentar la colaboración y coordinación con recursos que atienden específicamente mujeres y con la red de atención a víctimas de violencia de género.

• Ofrecer intervención a las personas sin hogar con adicciones en la red del Instituto de Adicciones y en la red de atención a las personas sin hogar.

- Garantizar a las personas con adicción sin hogar una atención adaptada a sus necesidades específicas.
- Ofrecer intervención a las PSH con adicciones in situ en la red de atención a las PSH.
- Promover la coordinación general y colaboración entre los recursos de la red de atención y la red de atención a PSH.

• Ofrecer a las familias de las personas con adicciones la atención, el apoyo y la orientación necesarios.

- Ofrecer a las familias de las personas en tratamiento una intervención que facilite el proceso terapéutico y el manejo de la adicción.
- Ofrecer orientación y estrategias a las familias de personas con problemas de adicción que no están en tratamiento.
- Mejorar la funcionalidad familiar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Atención y prevención de la adicción al juego.

• Prevenir las conductas de riesgo y adicción al juego y a los videojuegos mediante la sensibilización y otras actividades preventivas.

- Prevención y coordinación a través de los diferentes recursos del Ayuntamiento para los colectivos de menores de 25 años.
- Prevención y concienciación a través de los diferentes recursos del Ayuntamiento para los colectivos de mayores de 25 años.
- Formar a profesionales de educación, mediadores y agentes sociales.

• Tratamiento integral y especializada a las personas afectadas y sus familias.

- Ofertar tratamiento integral y especializado a las personas con trastorno por juego.
- Atención e intervención a las familias de las personas con trastorno por juego.

• Actuaciones específicas sobre zonas más vulnerables.

- Atender a las zonas con más incidencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Coordinación y trabajo en red.

• Desarrollar y mejorar las estrategias de coordinación con los grupos de interés

- Impulsar la coordinación con las redes internacionales en materia de adicciones.
- Desarrollar líneas permanentes de coordinación en materia de adicciones con el Plan Nacional sobre Drogas y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Impulsar la coordinación con la Comunidad de Madrid.
- Desarrollar líneas de coordinación y del trabajo en red con otras áreas del Ayuntamiento de Madrid.
- Apoyar al movimiento asociativo para el desarrollo de programas y recursos de prevención y de apoyo al tratamiento y a la reinserción en materia de adicciones.
- Desarrollar líneas de colaboración con universidades, colegios profesionales y sociedades científicas.
- Desarrollar líneas de coordinación y colaboración con la SG de Prevención y Promoción de Madrid Salud.

• Desarrollar las funciones de coordinación del Foro Técnico de Adicciones

- Propiciar las funciones de coordinación del Foro Técnico de Adicciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Calidad y mejora continua.

• Garantizar y potenciar la calidad en todos los niveles de la organización, actualizando y evaluando los procesos y los servicios prestados mediante el establecimiento de indicadores de gestión y estándares de calidad.

- Cumplir las actuaciones del Plan Operativo de Gobierno 2.019/2.023 y sucesivos.
- Gestionar por procesos.
- Mantener actualizado el CMI de forma continua.
- Implementar elaboración y revisión de buenas prácticas.
- Garantizar la seguridad clínica.
- Cumplir con los compromisos del sistema de sugerencias y reclamaciones de Madrid Salud.
- Sensibilizar al personal del Instituto de Adicciones en los compromisos y acciones de calidad.
- Fomentar un entorno seguro para la plantilla.
- Elaborar memoria anual.
- Evaluar los resultados de la intervención con las personas usuarias.
- Consolidar, ampliar y adaptar los instrumentos y sistemas de registro de la red del Instituto de Adicciones.

• Gestionar los servicios con eficacia y eficiencia, de forma participativa y transparente, mejorando de forma continua y rindiendo cuentas a la ciudadanía.

- Gestionar con efectividad los programas presupuestarios.
- Mantener compromisos con la ciudadanía en relación con la calidad de los servicios prestados.
- Evaluar la evolución del cumplimiento de las acciones integradas en el Plan de Adicciones.
- Cumplir el Plan de actuación anual.

- Cumplir la Carta de Servicios.

• Potenciar el desarrollo del conocimiento: formación, investigación y docencia.

- Compartir conocimiento.
- Fomentar la formación continuada de la plantilla.
- Facilitar que la plantilla importa docencia sobre adicciones.
- Facilitar y promocionar la realización de investigaciones en el ámbito de las adicciones.
- Compartir conocimiento.

CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

1.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.

Derechos.	. Recabar información para la prevención de adicciones. . Ser destinatarios de acciones de prevención generales o específicas. . Ser atendidos por los CAD en función de su necesidad. + **Derechos recogidos en la Ley 5/2.002.** . Igualdad de acceso a los dispositivos y respeto a su personalidad, dignidad e intimidad. . Asistencia en la red pública y en los centros privados concertados. . Información sobre servicios y recursos y requisitos. . Recibir tratamiento adecuado. . Voluntariedad para iniciar y cesar el proceso terapéutico. . Confidencialidad de toda la información. . Información, verbal o por escrito, del programa terapéutico individualizado. . Información adecuada, comprensible, verbal, o en su caso, escrita, sobre la medicación. . Certificación gratuita acreditativa sobre su situación. . Constancia por escrito o en soporte técnico de su proceso asistencial. . Ser advertido si el tratamiento puede ser utilizado para un proyecto docente de investigación. . Conocer el nombre y cualificación profesional de las personas que le atienden. . Saber a qué personas, unidades o servicios dirigirse para plantear cuestiones o quejas. . Cesar en la utilización de los servicios o permanencia en los centros por voluntad propia.

	. Conocer la normativa del centro. . Firma de un contrato terapéutico → derechos y deberes, eventual participación de la familia …
Responsabilidades.	**Obligaciones recogidas en la Ley 5/2.002.** - Cumplir con las especificaciones e indicaciones del tratamiento. - Respetar las normas de funcionamiento. - Someterse a las determinaciones toxicológicas indicadas. - Firmar la baja voluntaria en caso de negativa al tratamiento o abandono. - Responder a las cuestiones que le sean planteadas. - Tratar con respeto a todo el personal del centro y demás usuarios. - Conducta basada en el respeto mutuo, tolerancia y colaboración.

2.- SERVICIOS PRESTADOS.

. Servicio de Prevención de Adicciones (PAD).

. Reducción del Daño.

. Atención integral.

. Servicio de Orientación Laboral (SOL).

. Recursos residenciales de apoyo al tratamiento y la reinserción.

. Información.

. Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.